



GUIA ILUSTRADO PARA PAIS

Sibilância Recorrente

Quando o chiado no peito volta sempre:
o que investigar e como tratar

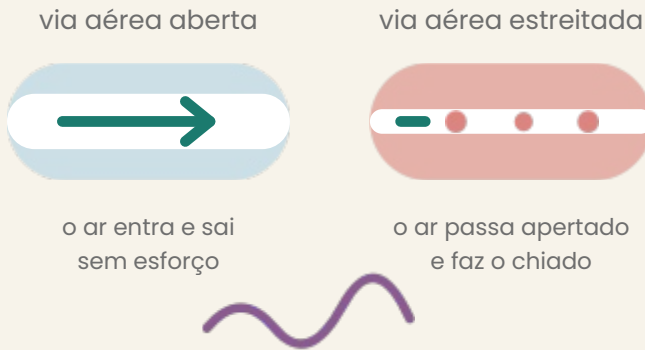
Dra. Ana Karina Fernandes

Pneumologista Pediátrica

CRM/RN 5751 • RQE 6271

O que é o chiado

Sibilância é o nome técnico do **chiado**: um som fino, como um assobio, que aparece principalmente quando a criança **solta o ar**.



Ele surge quando os brônquios ficam **estreitados** — pelo inchaço da parede, pelo muco acumulado e pela contração do músculo ao redor. O ar precisa passar por um espaço menor, e isso produz o som.

Chiado não é sinônimo de asma

Chiar é um **sinal**, não um diagnóstico — como febre. Várias condições diferentes produzem o mesmo som, e é por isso que a investigação importa: o tratamento certo depende da causa certa.

A DEFINIÇÃO

Quando o chiado passa a ser “recorrente”

Fala-se em sibilância recorrente quando a criança apresenta **três ou mais episódios** de chiado – nos primeiros anos de vida ou dentro dos últimos 12 meses.



Esse número não é um detalhe burocrático: a partir dele, aumenta a chance de haver uma causa de base que se beneficia de tratamento – e vale investigar em vez de tratar cada crise isoladamente.

Chiar é **muito comum** nos primeiros anos: cerca de **1 em cada 3 crianças** apresenta pelo menos um episódio até os 3 anos de idade. Frequente não significa banal – significa que merece ser bem avaliado.

O que pode causar

Quanto **menor a criança**, maior a lista de possibilidades — e por isso a avaliação de um chiado repetido não pode ser apressada:



Infecções virais

A causa mais comum nos pequenos: chia junto com o resfriado.



Asma

Principal causa a partir da idade escolar.



Refluxo e engasgos

Conteúdo que sobe do estômago irrita os brônquios.



Fumaça e alérgenos

Cigarro, mofo, ácaros e pelos mantêm a inflamação.



Corpo estranho aspirado

Objeto ou alimento inalado: chiado que começa de repente.



Outras causas

Fibrose cística, malformações, imunidade baixa.

Identificar a causa é o que permite sair do ciclo de tratar apenas a crise.

Meu filho vai ter asma?

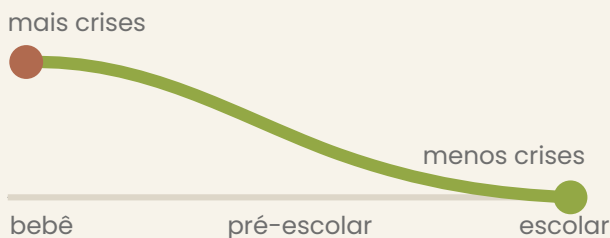
Ninguém consegue prever com certeza. Mas alguns fatores aumentam a chance de o chiado **persistir** e vir a se confirmar como asma:

Pesam mais

- **Pai ou mãe com asma**
- **Dermatite atópica** (eczema) na criança

Pesam um pouco menos

- **Rinite alérgica** na criança
- Chiado **fora dos resfriados**, sem infecção junto
- **Eosinófilos elevados** no exame de sangue



A maioria das crianças que chia nos primeiros anos deixa de chiar conforme cresce.

Sinais de que não é apenas asma



Estes achados sugerem que existe **outra causa por trás** do chiado e indicam avaliação especializada:

- ! Chiado desde o **período de recém-nascido**, sem intervalos livres
- ! **Dificuldade em ganhar peso** ou altura
- ! **Tosse úmida, com catarro, todos os dias**
- ! **Engasgos, vômitos** ou tosse durante as mamadas e refeições
- ! Chiado que começou **de repente**, durante uma brincadeira ou refeição
- ! Chiado sempre **do mesmo lado** do peito
- ! **Pneumonias de repetição** ou infecções graves em outros órgãos
- ! **Nenhuma resposta** ao tratamento adequadamente feito

Chiado que **não melhora com o tratamento** costuma significar diagnóstico incompleto — e não apenas necessidade de dose maior.

Como se trata

O tratamento é **individual**: depende da causa, da idade e da frequência das crises. Nem toda criança que chia precisa de medicação contínua.

1 Broncodilatador na crise

A “bombinha” de alívio: abre a passagem do ar rapidamente.

2 Corticoide inalatório de manutenção

Uso contínuo em casos selecionados, para desinflamar a via aérea.

3 Teste terapêutico

Tratar por 2 a 3 meses e observar a resposta ajuda no diagnóstico.

4 Controle do ambiente

Sem fumaça, com controle de mofo e ácaros. Pesa como um remédio.

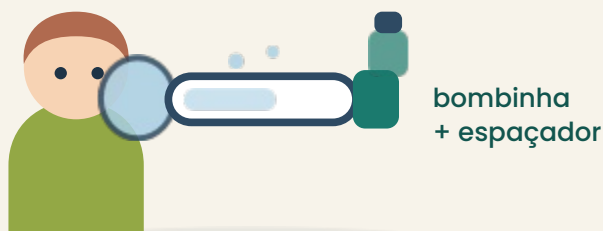
5 Tratar o que está associado

Rinite, refluxo e obesidade pioram o chiado.

Xarope não trata chiado. Antitussígenos, expectorantes e antibióticos não atuam no broncoespasmo e não devem substituir a medicação inalatória prescrita.

Até os 4 anos: espaçador com máscara

Nessa idade a criança ainda não consegue selar os lábios no bocal. Faça com ela **calma e sentada no colo** — chorar reduz muito a quantidade de remédio que chega ao pulmão.



1 Agite por 5 segundos

Antes de cada jato. Depois encaixe na entrada do espaçador.

2 Ajuste a máscara

Cobrindo nariz e boca, bem encostada, sem frestas.

3 Aplique um jato de cada vez

Nunca dois ou três jatos juntos dentro do espaçador.

4 Conte 10 respirações

Ou mantenha a máscara no rosto por cerca de 20 segundos.

5 Espere 30 a 60 segundos

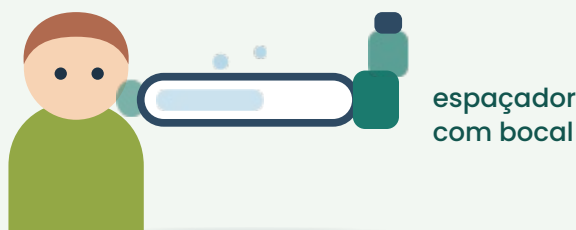
Agite de novo por 5 segundos e aplique o jato seguinte.

6 Limpe a boca ao final

Depois do corticoide, ofereça água ou limpe a boquinha.

De 4 a 5 anos: espaçador com bocal

A troca da máscara pelo bocal acontece quando a criança já consegue **fechar bem os lábios** e respirar pela boca sob comando — em geral por volta dos 4 anos. Na dúvida, mantenha a máscara.



1 Agite por 5 segundos

Antes de cada jato. Depois encaixe na entrada do espaçador.

2 Use o bocal, sem máscara

Lábios bem fechados em volta do bocal, sem escapar ar.

3 Solte o ar antes

Peça para esvaziar o peito antes de aplicar o jato.

4 Um jato e 6 respirações

Seis respirações lentas pelo bocal, sem tirar da boca.

5 Espere 30 a 60 segundos

Agite de novo por 5 segundos e aplique o jato seguinte.

6 Bochechar e cuspir

Depois do corticoide, lave a boca com água e cuspa.

NÃO ESPERE PASSAR

Quando ir ao pronto-socorro

Durante uma crise, procure atendimento imediato diante de **qualquer um** destes sinais:

- ! **Esforço para respirar:** afundamento entre as costelas, batimento das asas do nariz, gemido
- ! **Dificuldade para falar**, comer ou mamar por falta de ar
- ! Lábios ou rosto **arroxeados**
- ! **Sonolência** excessiva ou agitação intensa
- ! A bombinha de alívio **não faz mais efeito** ou o efeito dura pouco
- ! Chiado que **some junto com piora** do estado geral — sinal de pouca entrada de ar

O chiado que **desaparece** enquanto a criança piora é especialmente perigoso: significa que está entrando pouco ar, e não que a crise melhorou.

Tenha sempre em casa a medicação de alívio dentro da validade e o plano de ação escrito pela equipe.

Cuidados em casa



Casa sem fumaça de cigarro

A medida de maior impacto. Vale para varanda, carro e roupa.



Controle de mofo e umidade

Ventile os cômodos e trate infiltrações.



Quarto simples de limpar

Roupa de cama lavada com frequência, sem tapete nem cortina pesada.



Vacinas em dia

Sobretudo a da gripe: vírus são o principal gatilho das crises.



Deixe a criança se exercitar

Se o exercício desencadeia crises, o tratamento precisa de ajuste.



Registre as crises

Anote data, gatilho e o que foi usado. Ajuda muito na consulta.

Não suspenda a medicação de manutenção por conta própria quando a criança melhorar — é justamente ela que está mantendo a melhora.

Quando procurar o pneumologista pediátrico



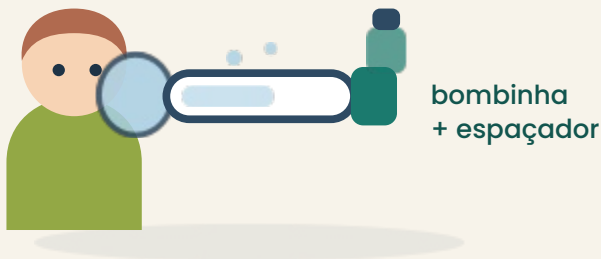
O pediatra conduz a maior parte dos casos. O especialista entra quando é preciso **esclarecer a causa** ou ajustar um tratamento que não vem funcionando:

- **Três ou mais episódios** de chiado, em qualquer idade
- Crises **graves**, com ida ao pronto-socorro ou internação
- Qualquer **sinal de alerta** das páginas anteriores
- Chiado que **começou antes dos 6 meses** de vida
- Necessidade frequente de **corticoide oral**
- Sintomas que **persistem** mesmo com tratamento bem feito
- Dúvida diagnóstica ou vontade de entender melhor o caso

Por que importa: crises repetidas e inflamação mantida podem comprometer o crescimento do pulmão. Definir a causa cedo evita anos de tratamento incompleto — e permite tratar o que de fato existe.

Resumo em seis lembretes

- ✓ Chiado é um **sinal**, não um diagnóstico.
- ✓ **Três episódios** já justificam investigar.
- ✓ Nem todo chiado é asma — e nem todo chiado some sozinho.
- ✓ A **técnica da bombinha** vale tanto quanto o remédio.
- ✓ Casa sem fumaça é tratamento.
- ✓ Esforço para respirar ou fala entrecortada: **pronto-socorro**.



Chiar sempre não é normal.
Tem causa — e tem tratamento.



Dra. Ana Karina Fernandes

Pneumologista Pediátrica

CRM/RN 5751

RQE 6271

Este material tem finalidade **educativa** e não substitui a consulta médica, o diagnóstico ou o tratamento indicado para o seu filho.

Conteúdo baseado no Guia Prático de Sibilância Recorrente do Lactente e Pré-escolar da Sociedade Brasileira de Pediatria, nas diretrizes SBP/ASBAI e nas recomendações GINA para menores de 5 anos.